

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-08
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 06
		FECHA: Enero 2025
		Página: 0 de 13

Contenido

1. JUSTIFICACIÓN	1
2. OBJETIVO	1
3. ALCANCE	2
4. RESPONSABILIDAD	2
5. DEFINICIONES	2
6. CONTENIDO	4
6.1 REACTIVO VIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
REPORTES	¡Error! Marcador no definido.
Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro	¡Error! Marcador no definido.
FALLAS POTENCIALES	¡Error! Marcador no definido.
6.2 FARMACOVIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO	11
REPORTES	¡Error! Marcador no definido.
3.2 TECNIVIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
DISPOSITIVOS MEDICOS OBJETO DE VIGILANCIA	¡Error! Marcador no definido.
REPORTES	¡Error! Marcador no definido.
16. BIBLIOGRAFIA	¡Error! Marcador no definido.
9. REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES	12

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 1 de 13

1. JUSTIFICACIÓN

La **farmacovigilancia** es el proceso de detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Su objetivo es garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos en la población.

En Colombia, la **farmacovigilancia** está regulada principalmente por el **Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)** y está regida por normativas que buscan asegurar la salud pública y proteger a los pacientes de riesgos relacionados con los medicamentos.

2. OBJETIVO

El objetivo principal de este manual es proporcionar una guía clara y accesible para la implementación efectiva del sistema de farmacovigilancia en Colombia, conforme a las normativas vigentes. Este manual tiene como fin:

1. **Garantizar la seguridad del uso de medicamentos:** Asegurar que los medicamentos que llegan al mercado colombiano sean seguros y eficaces para la población, a través de un sistema de monitoreo constante de sus efectos adversos.
2. **Promover la cultura de notificación de eventos adversos:** Incentivar a los profesionales de la salud, la industria farmacéutica, y los pacientes a identificar, documentar y notificar cualquier evento adverso relacionado con medicamentos, contribuyendo a la detección temprana de riesgos.
3. **Cumplir con las normativas colombianas:** Asegurar que las entidades involucradas en la cadena de suministro y uso de medicamentos cumplan con las disposiciones legales, como las establecidas por INVIMA, para proteger la salud pública.
4. **Facilitar la toma de decisiones informadas:** Proveer herramientas para la evaluación y análisis de los riesgos asociados con los medicamentos, para que las autoridades competentes tomen decisiones fundamentadas, como cambios en el etiquetado, alertas sanitarias o la retirada de productos del mercado.
5. **Educar y sensibilizar:** Proporcionar formación continua a los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y la población general, con el fin de fortalecer el sistema de farmacovigilancia y mejorar la calidad del sistema de salud en Colombia.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 2 de 13

3. ALCANCE

Este Programa incluye desde la adquisición, la identificación, registro, notificación hasta el control del riesgo detectado con fármacos empleados en la prestación del servicio del Laboratorio Clínico Especializado Martha Cecilia Perdomo IPS.

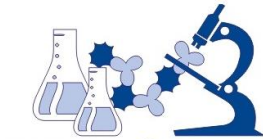
4. RESPONSABILIDAD

Todo el personal deberá reportar en el aplicativo de seguridad del paciente los incidentes y/o eventos adversos, cada que identifiquen o tengan conocimiento de que un reactivo, fármacos y dispositivos médicos, causó o es sospechoso de causar un evento o incidente adverso, para ser analizado por comité de seguridad el paciente.

Además la dirección designara un referente de cada uno de los programas de vigilancia.

5. DEFINICIONES

- **Farmacovigilancia:** Es el conjunto de actividades y procedimientos relacionados con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Su objetivo es asegurar la seguridad y eficacia de los medicamentos en el mercado.
- **Evento Adverso:** Cualquier manifestación nociva e involuntaria que ocurra tras la administración de un medicamento, ya sea que esté relacionado o no con el uso del mismo. Los eventos adversos incluyen efectos secundarios, reacciones alérgicas, toxicidad y cualquier otro tipo de daño a la salud causado por un medicamento.
- **Reacción Adversa:** Es un tipo específico de evento adverso que ocurre como una respuesta perjudicial a un medicamento, la cual está asociada con su administración correcta, dentro de las dosis recomendadas.
- **Sospecha de Evento Adverso:** Se refiere a la presunción de que un medicamento ha ocasionado un evento adverso en un paciente, aunque no haya una confirmación definitiva o científica sobre la relación causal.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 3 de 13

- **Notificación de Eventos Adversos:** Es el proceso mediante el cual los profesionales de la salud, los pacientes o cualquier otra persona informan a las autoridades sanitarias o a los fabricantes sobre la ocurrencia de un evento adverso asociado a un medicamento.
- **Sistema de Notificación de Eventos Adversos:** Es el sistema formal y estructurado creado por INVIMA para recibir, registrar, analizar y dar seguimiento a los reportes de eventos adversos. En Colombia, este sistema es gestionado a través de la plataforma electrónica de INVIMA.
- **Relación Riesgo-Beneficio:** Es el análisis realizado para determinar si los beneficios que aporta un medicamento superan los riesgos asociados a su uso. En caso de que los riesgos sean mayores que los beneficios, las autoridades pueden tomar decisiones como la suspensión o modificación del medicamento.
- **Alerta Sanitaria:** Es una notificación formal emitida por INVIMA u otras entidades competentes para informar sobre un riesgo grave relacionado con un medicamento o producto biológico. Las alertas sanitarias buscan prevenir daños a la salud de la población, indicando acciones específicas como la retirada del mercado o la modificación de las indicaciones de uso.
- **Farmacoepidemiología:** Es el estudio de los efectos y usos de los medicamentos en las poblaciones, con el objetivo de entender mejor su perfil de seguridad y eficacia a gran escala, a través de la recopilación de datos y la observación.
- **Medicación Off-label (Uso No Aprobado):** Es el uso de un medicamento para una indicación, dosis o grupo de pacientes diferente al que fue aprobado por las autoridades sanitarias. Este uso debe ser documentado cuidadosamente, ya que puede implicar riesgos no evaluados durante los estudios clínicos.
- **Medicamento:** Es cualquier sustancia o combinación de sustancias que se presenta como un tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades, y que está sujeta a la regulación de las autoridades sanitarias para garantizar su seguridad, eficacia y calidad.
- **Farmacovigilancia Post comercialización:** Es el proceso continuo de monitoreo de la seguridad de los medicamentos una vez que estos han sido aprobados y están disponibles en el mercado. Involucra la recopilación de datos a través de la notificación de eventos adversos y otras fuentes, con el objetivo de identificar riesgos inesperados.
- **Informe de Casos:** Es un documento formal que detalla un evento adverso específico, proporcionando información sobre el paciente, el medicamento involucrado, los síntomas y las acciones tomadas. Este informe es esencial para la evaluación y seguimiento de la seguridad de un medicamento.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 4 de 13

- Estudio de Seguridad de Medicamentos: Son investigaciones científicas diseñadas para evaluar los efectos a largo plazo y la seguridad de los medicamentos, especialmente aquellos que están en uso generalizado en la población.
- Sistema de Gestión de Riesgos: Conjunto de procesos y procedimientos utilizados por las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados con los medicamentos en el mercado.
- Vigilancia de la Calidad del Medicamento: Se refiere a las actividades que buscan asegurar que los medicamentos, tanto en la fabricación como en su distribución, mantengan los estándares de calidad establecidos para garantizar su seguridad y eficacia.

6. CONTENIDO

2. Marco Normativo de la Farmacovigilancia en Colombia

Las principales normativas que regulan la farmacovigilancia en Colombia son:

- **Ley 100 de 1993:** Establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud y tiene disposiciones sobre el control de la calidad de los productos farmacéuticos.
- **Resolución 1403 de 2007:** Regula la vigilancia de los medicamentos y productos biológicos en Colombia.
- **Decreto 4725 de 2005:** Regula la comercialización, el registro y la vigilancia de medicamentos.
- **Resolución 2013 de 2015:** Establece los lineamientos técnicos para la gestión de los riesgos derivados de los medicamentos en el país.
- **Circular Externa 012 de 2017:** Emite directrices para el reporte de eventos adversos de medicamentos a través del sistema de notificación.

3. Responsabilidades en el Sistema de Farmacovigilancia

3.1. INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)

El INVIMA es la entidad encargada de:

- Recibir, analizar e investigar los reportes de eventos adversos.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 5 de 13

- Realizar evaluaciones de seguridad de medicamentos en el mercado.
- Regular y aprobar las actividades de farmacovigilancia.
- Promover la educación y sensibilización sobre la farmacovigilancia.

3.2. Profesionales de la Salud

Los médicos, farmacéuticos, odontólogos y otros profesionales de la salud tienen la obligación de:

- Informar cualquier evento adverso o sospecha de evento adverso relacionado con el uso de medicamentos.
- Completar adecuadamente los formularios de notificación de eventos adversos.
- Brindar información a los pacientes sobre los riesgos potenciales de los medicamentos.

3.3. Fabricantes, Distribuidores y Comerciantes de Medicamentos

Los laboratorios y compañías farmacéuticas tienen la responsabilidad de:

- Mantener un sistema de farmacovigilancia interno.
- Reportar los eventos adversos que reciban directamente o a través de los usuarios.
- Mantener actualizada la información de seguridad de los productos en el mercado.

3.4. Pacientes

Los pacientes o sus representantes tienen la responsabilidad de:

- Informar a los profesionales de la salud sobre cualquier efecto adverso experimentado.
- Participar en la vigilancia de los productos farmacéuticos.

¿Qué es la red nacional de farmacovigilancia?

Conjunto de personas e instituciones que mantienen contacto entre sí, a través de reportes de eventos adversos, comunicaciones e información en relación con problemas de seguridad o uso correcto de medicamentos. La red incorpora personas o instituciones establecen contactos permanentes con el programa de Farmacovigilancia del INVIMA.

Todos los actores de la red deben estar inscritos en esta.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 6 de 13

4. Procedimiento para Reportar Eventos Adversos

1. **Identificación del Evento Adverso:** Un evento adverso puede incluir reacciones no deseadas, efectos secundarios graves, interacciones medicamentosas, entre otros.
2. **Notificación:** La notificación de eventos adversos debe realizarse de manera oportuna, usando el formulario estándar proporcionado por INVIMA.
 - Se puede realizar en línea a través de la plataforma de INVIMA o mediante formularios físicos.
3. **Análisis y Evaluación:** El INVIMA evalúa la información para determinar si hay riesgos asociados con el medicamento y si se requieren medidas adicionales como alertas sanitarias o modificaciones en el etiquetado.
4. **Seguimiento:** En algunos casos, el INVIMA realiza seguimiento al evento adverso para obtener más detalles sobre el caso y prevenir futuros riesgos.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 7 de 13

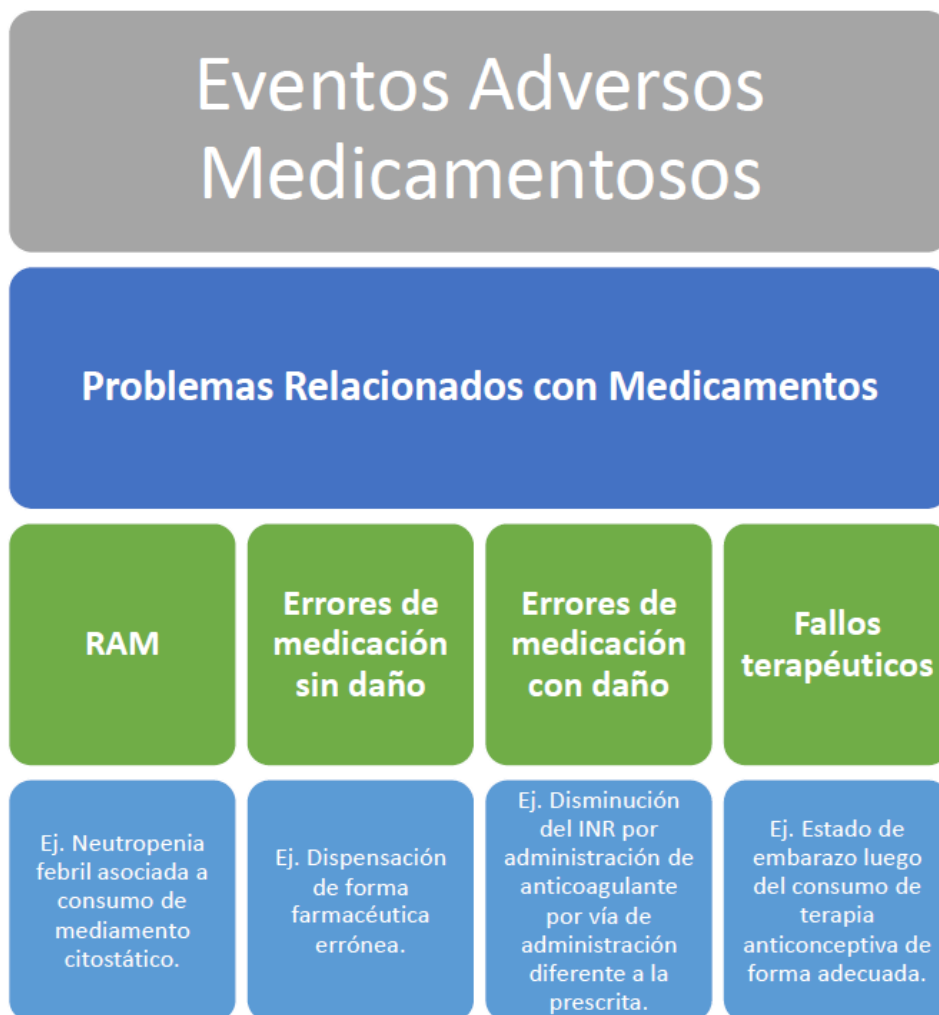


Figura 2 – Tipos de PRM

Posterior a la identificación del tipo de PRM, la IPS **clasificará el caso como grave o no grave**. Para esto, recordar lo establecido en la Resolución 1403 de 20077 y las definiciones mostradas más arriba. Esta clasificación puede realizarse por el Servicio Farmacéutico en unidad de análisis independiente del Comité de Farmacovigilancia o mediante metodología que permita cumplir, en todo momento, los tiempos de reporte al programa territorial de farmacovigilancia, señalados en la normatividad vigente.

Los *PRM Graves* son todos aquellos que deriven en alguna de las siguientes situaciones:

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 8 de 13

- Muerte
- Discapacidad
- Amenaza de la vida
- Anomalía congénita
- Causa o prolongación de la hospitalización

También es posible clasificar un PRM como grave de acuerdo con los criterios que defina el profesional sanitario tratante, de acuerdo con la severidad de la afectación que haya sufrido el paciente en particular.

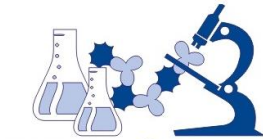
Todo caso de PRM que no se clasifique dentro de los criterios anteriores se clasifica como *No Grave*.

Los **PRM graves** cuentan con 72 horas después de su notificación al PIF para ser reportados en VigiFlow®, lo que es, por ejemplo, para un PRM Grave ocurrido el 9 de febrero, la IPS cuenta hasta el 12 de febrero para completar y delegar el reporte en VigiFlow®. Los **PRM No graves** se pueden reportar *hasta* el 5to día del mes siguiente a su ocurrencia, es decir, para un caso no grave ocurrido entre el 1ro y el 31 de marzo, la IPS reportante tiene hasta el 5 de abril para completar y delegar el reporte en VigiFlow®.

Una vez realizada la clasificación inicial, la unidad de análisis interdisciplinar deberá utilizar la metodología adecuada para evaluar el caso individual, según se haya definido en el PIF. Se recuerda que para **las RAM se debe siempre realizar una evaluación de causalidad**, la cual debería estar basada en la metodología de causalidad de la OMS-UMC preferiblemente; también es permitido el algoritmo de Naranjo, el método francés u otros, según lo defina la IPS. En todo caso deberá indicarse un resultado de nexo causal entre la RAM y el medicamento sospechoso, el cual deberá estar sustentado en el análisis realizado por la Unidad de Análisis de acuerdo con el Estado del Arte en Farmacovigilancia.

Para los **errores de medicación sin daño** se sugiere realizar un análisis de causa efecto (Ishikawa) o la evaluación por Protocolo de Londres que explique la ocurrencia del evento. Para los **errores de medicación con daño** deberá entenderse el daño como una RAM, por lo que se realizarán dos análisis, uno del error de medicación usando análisis de causa-efecto (Ishikawa) o Protocolo de Londres y otro específico para el daño o RAM, que deberá contar, por supuesto, con una evaluación de causalidad.

Para los **Fallos Terapéuticos**, se sugiere implementar análisis de causa-efecto.

 LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MARTHA CECILIA PERDOMO IPS	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 9 de 13

(Ishikawa), Protocolo de Londres, el Algoritmo de Vaca o cualquier otra metodología que permita analizar y concluir sobre el caso.

5. Sistema de Notificación de Eventos Adversos



IPS que requieren usuario

1. Solicitud y Activación de usuario en VigiFlow®

1.1. Las instituciones que tendrán acceso directo al Sistema VigiFlow® serán las IPS públicas y privadas que tengan habilitado el Servicio Farmacéutico o aquellas que en la prestación de servicios de salud contemplen la prescripción, la dispensación o la administración de medicamentos, así no tengan habilitado el Servicio Farmacéutico. También se incluye aquellas IPS del régimen de excepción o con objeto social diferente.

1.5. Las IPS contarán con un usuario en VigiFlow® que les será asignado por una única vez, independiente del profesional de la salud referente del Programa de Farmacovigilancia institucional.

1.6. Las IPS que cuenten con diferentes sedes a nivel nacional, deberán solicitar un acceso a VigiFlow® por cada sede, a cada Dirección Territorial de Salud de la jurisdicción respectiva, con una cuenta de correo electrónico institucional diferente en cada una.

www.invima.gov.co

El INVIMA ha establecido un sistema electrónico que permite la notificación rápida y sencilla de eventos adversos:

- **VIGIFLOW:** La notificación se puede realizar a través de la página oficial de INVIMA, donde los profesionales de la salud y los pacientes pueden ingresar los datos de los eventos.
- **Sistema de Reporte:** Los reportes deben incluir detalles sobre el medicamento, la reacción adversa, el paciente afectado y el tratamiento recibido.

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 10 de 13

Usuario: labmarthaperdomo
Contraseña: 34530326

6. Evaluación de Riesgos y Toma de Decisiones

La evaluación de riesgos de un medicamento involucra:

- La identificación de riesgos asociados con el uso del medicamento.
- La evaluación de la relación riesgo-beneficio del medicamento en la población.
- Las acciones posibles, que incluyen modificaciones en las recomendaciones de uso, actualizaciones en el etiquetado, restricciones de uso o retirada del mercado.

7. Educación y Capacitación

Es fundamental que los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y la comunidad en general reciban formación continua sobre los aspectos clave de la farmacovigilancia. Esto incluye:

- Talleres sobre la identificación y notificación de eventos adversos.
- Actualización sobre normativas nacionales e internacionales.
- Promoción de la cultura de seguridad del paciente.

8. Alertas Sanitarias

El INVIMA tiene la autoridad para emitir **alertas sanitarias** cuando se identifican riesgos graves asociados con un medicamento. Estas alertas pueden incluir advertencias sobre efectos adversos graves, cambios en las indicaciones de uso, o incluso la suspensión temporal o definitiva de un medicamento en el mercado.

9. Conclusiones

La farmacovigilancia es un componente esencial para garantizar la seguridad de los medicamentos en Colombia. Las autoridades, los profesionales de la salud, los fabricantes y

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	VERSIÓN: 05
		FECHA: Enero 2025
		Página: 11 de 13

los pacientes tienen responsabilidades compartidas para identificar y notificar los riesgos asociados con los medicamentos. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre el uso de los medicamentos y a proteger la salud pública.

La normatividad colombiana en farmacovigilancia establece un sistema integral que involucra tanto la detección como la evaluación y la prevención de riesgos, y garantiza que los medicamentos disponibles en el país sean seguros y eficaces para la población.

FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO

N°	NOMBRE DEL FARMACO	NIVEL DE RIESGO
1	Carga de glucosa	I
2	Alcohol	I
3	Solución salina	I

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código: PS.MF-11
	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA		VERSIÓN: 05
			FECHA: Enero 2025
			Página: 12 de 13

9. REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA
01	Entrada en vigencia	Calidad	Mayo 2014
02	Actualización	Calidad	Agosto 2014
03	Actualización	Calidad	Marzo 2015
04	Actualización	Calidad	Marzo 2016
04	Revisión	Calidad	Marzo 2017
04	Revisión	Calidad	Marzo 2018
04	Revisión	Calidad	Marzo 2019
04	Revisión	Calidad	Marzo 2020
04	Revisión	Calidad	Marzo 2021
05	Actualización	Calidad	Marzo 2022
04	Revisión	Calidad	Enero 2023
04	Revisión	Calidad	Enero 2024
05	Actualización	Calidad	Enero 2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO
 Firma:	Firma: 	 Firma:
Cargo: Bacterióloga pruebas especiales	Cargo: Coordinadora de Calidad	Cargo: Director Laboratorio
Fecha: Enero 2025	Fecha: Enero 2025	Fecha: Enero 2025